

- 76★★★
☑☑☑ 健常者と喘息患者を鑑別する FeNO のカットオフ値は 35 ppb である。
- 77★★★
☑☑☑ 未治療時の FeNO 高値は、ICS の有用性を予測する指標である。
- 78★★★
☑☑☑ 治療下で FeNO が高値で症状が残存する場合は、アドヒアランスや吸入手技を再確認する。
- 79★★★
☑☑☑ アレルギー性鼻炎では FeNO が低下する。
- 80★★★
☑☑☑ 治療前の FeNO 低値例では FeNO の経時的変化が抗炎症治療の効果の評価に有用であることが多い。
- 81★★★
☑☑☑ FeNO は喘息の予後予測マーカーとして、増悪リスクと関連している。
- 82★★★
☑☑☑ ピークフロー (peak expiratory flow: PEF) は努力呼出時の最大呼気流量であり、気道閉塞を評価可能である。
- 83★★★
☑☑☑ PEF は 1 秒量 (FEV1) と相関しない。
- 84★★★
☑☑☑ PEF は喘息の診断に有用である。
- 85★★★
☑☑☑ PEF メーターを用いて計画的な治療管理を行った場合に、一定の基準を満たす医療機関において喘息治療管理料を算定することができる。
- 86★★★
☑☑☑ 気道過敏性および気道可逆性の存在は喘息診断の目安となる。
- 87★★★
☑☑☑ 気道可逆性の評価には SABA 吸入前後の FEV1 が 12% 以上かつ 200 mL 以上改善した場合に気道可逆性の存在を疑う。
- 88★★★
☑☑☑ 気道過敏性検査は、サルブタモールを低濃度から吸入させ、少しずつ濃度を上げて複数回の検査を行うことで気道収縮を評価する。
- 89★★★
☑☑☑ 気道過敏性検査では、気管支収縮薬の濃度を段階的に上げていき、FEV1 が吸入前と比較して 20% 以上低下した場合に陽性と判断される。
- 90★★★
☑☑☑ β_2 刺激薬は気道可逆性検査前に中止することが望ましい。
- 91★★★
☑☑☑ 喘息コントロールの評価として ACT (Asthma Control Test) などの質問票がある。